

LAUDO NEUROPSICOLÓGICO

1. IDENTIFICAÇÃO:

EXAMINANDO: VINICIUS ROSA DE LIMA
IDADE 19 ANOS NASCIMENTO 15/03/2005
ESCOLARIDADE: SUPERIOR CURSANDO
PROFISSÃO: ESTUDANTE
QUEIXA: INVESTIGAÇÃO COMPOTAMENTAL
AUTOR: ANDERSON PINHEIRO DE SOUZA CRP/02-23796

2. DESCRIÇÃO DA DEMANDA:

O Paciente procurou a Clinicall Saúde Integrada para realiza avaliação neuropsicológica com solicitação do psiquiatra, relacionado ao Tea e tdah, com queixa. O mesmo se mostrou solícitao a avaliação, compreendendo as informações passado pelo profissional.

3. PROCEDIMENTOS:

Realizado Avaliação Neuropsicológica, e foram utilizados como instrumentos de avaliação: a observação clínica do comportamento da mesma; a entrevista clínica e anamnese com a mesma.

Avaliação Neuropsicológica com uso dos instrumentos:

- Escala ETDAH- AD
- Teste de Inteligência geral não-verbal TRI;
- Teste de Figuras Complexas de Rey;
- Bateria Psicológica de Avaliação da Atenção- BPA 2;
- Teste de Memória 2- TEPIC e
- Escala para Tea- SRS2

4. VERIFICAÇÃO DOS TESTES APLICADOS:

No Teste de ETDAH- Escala de Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade e Déficit de Atenção.

Interpretação dos Resultados:



No fator Desatenção (D) o resultado é **Superior** o que indicada que é **Resultado Compatível com prejuízos Importantes e sérias dificuldades sendo considerado nível grave.**

No fator Impulsividade (I) é **Médio Superior** o que indicada que é **Resultado Compatível com prejuízos Importantes e sérias dificuldades sendo considerado nível moderado.**

No fator Aspectos Emocionais (AE) é **Superior** o que indicada que é **Resultado Compatível com prejuízos Importantes e sérias dificuldades sendo considerado nível grave.**

No fator Autorregulação da Atenção, da Motivação e da Ação (AMMA) é **Superior** o que indicada que é **Resultado Compatível com prejuízos Importantes e sérias dificuldades sendo considerado nível grave.**

No fator Hiperatividade (H) o resultado é **Médio Superior** o que indicada que é **Resultado Compatível com prejuízos Importantes e sérias dificuldades sendo considerado nível moderado.**

VISÃO GERAL/ ANÁLISE:

A Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção (BPA) tem como objetivo realizar **avaliação da capacidade geral da atenção**, assim como uma avaliação individualizada de tipos de atenção específico, quais sejam, Atenção Concentrada, Atenção Dividida e Atenção Alternada. As aplicações foram feitas na seguinte ordem: **1-Atenção Concentrada, 2- Atenção Dividida e 3-Atenção Alternada.** Neste instrumento o paciente obteve os seguintes resultados de acordo com a faixa etária:

Avaliação	Pontos	Percentil	Classificação
1-ATENÇÃO CONCENTRADA	80	30	MÉDIO INFERIOR
2-ATENÇÃO DIVIDA	70	25	MÉDIO INFERIOR
3-ATENÇÃO ALTERNANDA	116	80	MÉDIO SUPERIOR
ATENÇÃO GERAL	266	50	MÉDIO

A **atenção concentrada** é a capacidade de manter o foco atencional em um determinado estímulo durante um período de tempo. A **atenção dividida** é a capacidade do indivíduo realizar mais de uma atividade simultaneamente ou seja processa a resposta ou reagir duas ou mas demandas ao mesmo tempo, já na **atenção alternada**, espera-se que o indivíduo execute alternadamente, mais de uma tarefa.



Teste Pictórico de Memória – TEPIC-M Tem como objetivo avaliar

A capacidade do indivíduo de recuperar uma informação num curto período de tempo. Neste instrumento a pontuação obtida pela paciente foi:

Pontos	Percentil	Classificação
20	80	SUPERIOR

De acordo com a faixa etária.

Teste de Inteligência – (TRI) Teste Rápido de Inteligência, tem como objetivo avaliar a capacidade da inteligência das pessoas.

Pontos	Percentil	Classificação
15	99	SUPERIOR

De acordo com a faixa etária.

Escala de avaliação da Ansiedade de Hamilton - concentra-se na ansiedade psíquica e na ansiedade somática, que são os estresses psicológicos e os problemas físicos, respectivamente, causados pela ansiedade severa. Essa escala mede a extensão ou gravidade dos sintomas de ansiedade física e mental em uma pessoa. Ele também avalia o impacto de medicamentos e terapias anti-ansiedade e alívio do estresse.

Pontos	Classificação
14	ANSIEDADE PATOLOGICA

O Teste Figuras Complexas de Rey foi utilizado com o intuito de avaliar as **Funções Executivas**: habilidades de organização visuoespacial, atividade perceptiva, planejamento e desenvolvimento de estratégias, bem como memória visual, foi usado a forma A: cartão com uma figura complexa abstrata. Como se trata de um desenho a mão livre, não se levou em consideração a proporcionalidade, mas sim a presença e localização dos elementos.

Pontuação da paciente na reprodução de cópia da figura indica **Classificação Médio**, o que denota uma **dificuldades na capacidade de percepção visual, organização visuoespacial e planejamento**. O desempenho nas reproduções de memória (curto e longo prazo) sugerem a (**Classificação Médio Inferior**) na capacidade de memória visual, realizando uma cópia com poucas omissões de elementos da figura.

Orientação Têmporo-Espacial

A orientação é a função cognitiva associada à consciência do indivíduo sobre a situação real e atual em que se encontra em dado momento e depende, assim, da integridade das noções de identidade, de tempo e de espaço. Na avaliação da Orientação Têmporo-Espacial, a paciente apresenta resultado satisfatório.

O Teste de Aprendizagem Auditivo Verbal de Rey- RAVLT visa a avaliar a memória declarativa e episódica e fornecer informações sobre as medidas de aprendizagem de auditivo verbal, índices de interferência e de retenção de informações e memória de reconhecimento. O resultados do paciente mostram desempenho (**Classificação Médio**) na fase inicial RAVLT que avalia a capacidade de manter temporariamente um conteúdo verbal que lhe foi apresentado e mantém o desempenhos nas etapas seguintes do teste. Na fase de reconhecimento o examinado apresenta um desempenho tendo a (**Classificação Superior**), o reconhecimento é capacidade de recuperar a informação no passado que nos permite reconhecer pessoas, lugares, situações



Perfil de escores

Escala de Responsividade Social - 2 · Adulto Autorrelato
Adulto Autorrelato · Escore T (50+10z)

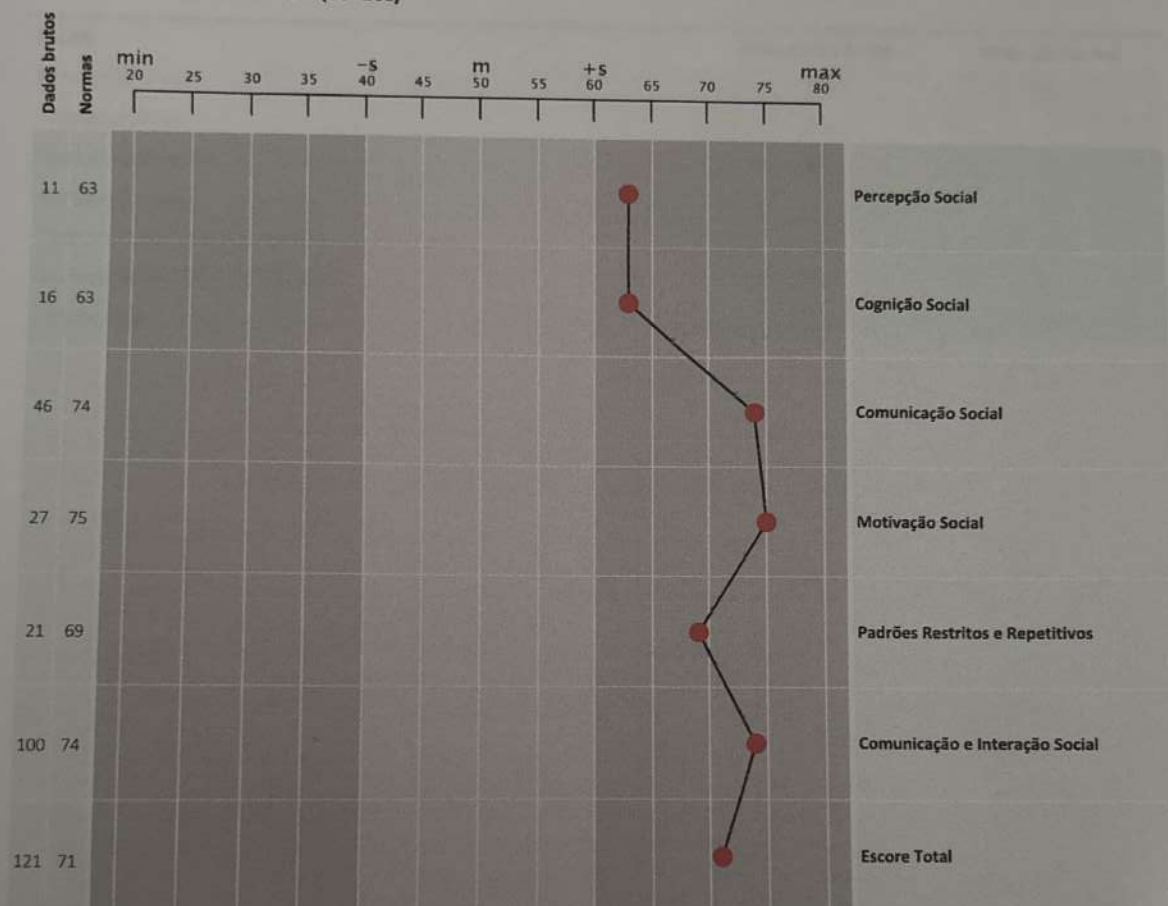


Tabela de escores

Escala de Responsividade Social - 2 - Adulto Autorrelato
Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Escala	Pontuação bruta	Valor da norma
Percepção Social	11	63
Cognição Social	16	63
Comunicação Social	46	74
Motivação Social	27	75
Padrões Restritos e Repetitivos	21	69
Comunicação e Interação Social	100	74
Escore Total	121	71

Cognição Social

Índice de Responsividade Social - 2 (SRS-2)

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

Índice de Responsividade Social - 2

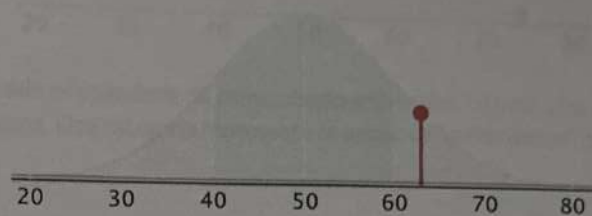
Índice de Responsividade Social - 2

Detalhes da escala

Percepção Social

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Pontuação bruta	11
Valor da norma	63
Respostas faltantes (missing)	0
Intervalo de confiança	[59 - 67]

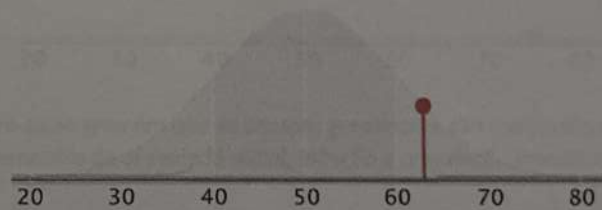


A Subescala de Intervenção de Percepção Social mede a capacidade de reconhecer pistas sociais e lidar com os aspectos da percepção do comportamento social recíproco.

Cognição Social

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Pontuação bruta	16
Valor da norma	63
Respostas faltantes (missing)	0
Intervalo de confiança	[59 - 67]

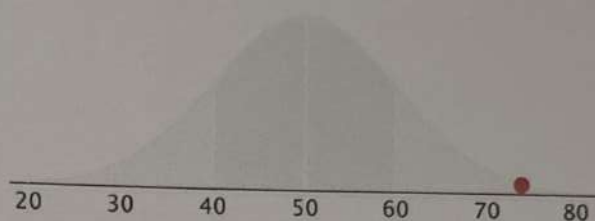


A Subescala de Intervenção Cognição Social refere-se à capacidade de interpretar as pistas sociais após reconhecê-las e lidar com o aspecto cognitivo-interpretativo do comportamento social recíproco.

Comunicação Social

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Pontuação bruta	46
Valor da norma	74
Respostas faltantes (missing)	0
Intervalo de confiança	[70 - 78]

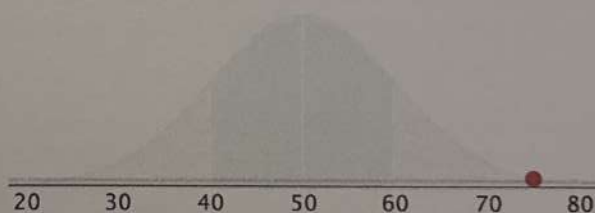


A Subescala de Intervenção Comunicação Social mede a capacidade de comunicação expressiva, lidando com os aspectos motores do comportamento social recíproco. Esta categoria representa os aspectos "motorizados" do comportamento.

Motivação Social

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Pontuação bruta	27
Valor da norma	75
Respostas faltantes (missing)	0
Intervalo de confiança	[71 - 79]

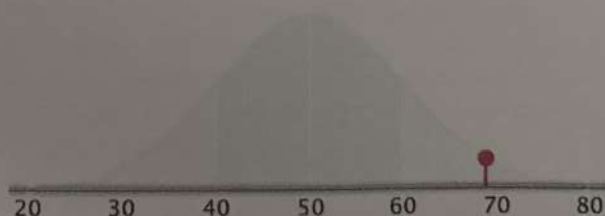


A Subescala de Intervenção Motivação Social refere-se ao grau em que as pessoas geralmente são motivadas a se engajar em comportamento sócio interpessoal. Elementos de ansiedade social, inibição e orientação empática estão incluídos entre esses itens.

Padrões Restritos e Repetitivos

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Pontuação bruta	21
Valor da norma	69
Respostas faltantes (missing)	0
Intervalo de confiança	[65 - 73]

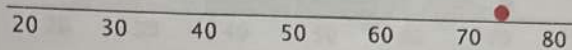


Padrões Restritos e Repetitivos encontra-se tanto nas subescalas de intervenção quanto nas escalas compatíveis ao DSM-5. Esta categoria mede a presença de comportamentos estereotípicos característicos de TEA e áreas de interesse muito limitadas.

Comunicação e Interação Social

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Pontuação bruta	100
Valor da norma	74
Respostas faltantes (missing)	0
Intervalo de confiança	[70 - 78]



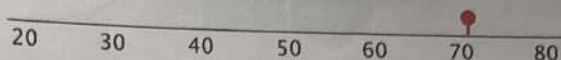
Comunicação e Interação Social é uma das escalas compatíveis ao DSM-5 e é uma medida global que se relaciona tanto à capacidade de reconhecer e interpretar sinais sociais quanto à capacidade de motivação para o contato interpessoal social expressivo. Ela avalia a reciprocidade socioemocional, comportamentos comunicativos não verbais usados para interação social e capacidade de desenvolver, manter e compreender relacionamentos.

Escore Total

DETALHES DA ESCALA SRS-2 8/12

Adulto Autorrelato - Escore T (50+10z)

Pontuação bruta	121
Valor da norma	71
Respostas faltantes (missing)	0
Intervalo de confiança	[67 - 75]



A SRS-2 oferece em seu relatório uma descrição detalhada da interpretação dos resultados a partir do escore T (métrica padronizada que permite avaliar quantos desvios o avaliando se distanciou da média, que é fixada em 50 e o seu desvio-padrão, em 10 pontos). Na plataforma HTS 5 é possível utilizar também o percentil (que se trata de um ranqueamento, uma classificação de posições, o que possibilita a comparação do desempenho do avaliando em relação ao grupo normativo).

Escore-T 59 e abaixo – Dentro dos limites normais

As pontuações neste intervalo geralmente não estão associadas ao Transtorno do Espectro Autista clinicamente significativos. Indivíduos com autismo muito leve podem mostrar pontuações na extremidade superior do nível normal se estiverem bem ajustados e a sua funcionalidade adaptativa estiver relativamente intacta.

Escore-T entre 60 e 65 – Nível leve

As pontuações neste intervalo indicam prejuízos no comportamento social recíproco que são clinicamente significativos e podem levar a uma interferência de leve a moderada nas interações sociais cotidianas. Essas pontuações são vistas em indivíduos com condições do espectro autista leve ou de alto funcionamento. Essas pontuações também são observadas ocasionalmente em indivíduos não afetados pelo autismo, mas que têm prejuízos na reciprocidade social relacionados ao Transtorno de Personalidade Esquizoide, Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), Transtornos de Ansiedade, Transtornos Psicóticos e alterações cognitivas leves a moderadas. As pessoas desta faixa podem se encaixar no diagnóstico DSM-5 estabelecido para Transtorno de Comunicação Social se não forem encontrados critérios clínicos para um diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. Indivíduos que estão na extremidade inferior deste intervalo podem ser razoavelmente bem ajustados quando não comorbidamente afetados por outras condições psiquiátricas.

Escore-T entre 66 e 75 – Nível moderado

As pontuações neste nível da escala indicam prejuízos no comportamento social recíproco que são clinicamente significativos e levam a uma interferência substancial nas interações sociais cotidianas. Essas pontuações são típicas em indivíduos com Transtorno do Espectro Autista de gravidade moderada, incluindo os diagnósticos DSM-IV para Transtorno do Autismo e para Síndrome de Asperger e os diagnósticos DSM-5 estabelecidos para Transtorno de Comunicação Social e Transtorno do Espectro Autista. As pontuações nesta escala também são comuns para indivíduos com Transtorno de Personalidade Esquizoide.

Escore-T 76 e acima – Nível severo

As pontuações neste nível da escala indicam prejuízos no comportamento social recíproco que são clinicamente significativos e levam a uma interferência severa e duradoura nas interações sociais cotidianas. Essas pontuações estão fortemente associadas ao Transtorno do Espectro Autista, de acordo com o DSM-V.

Estatísticas das respostas

Distribuição das respostas

Resposta	Percentu
1	6 %
2	26 %
3	38 %
4	29 %

Informações extras

Desculpe, as informações extras não estão disponíveis para esta avaliação. Possivelmente essa é uma correção informatizada de uma avaliação feita em lápis e papel.

As informações extras são geradas quando um examinando troca a janela do teste por outra janela do computador

CONCLUSÃO:



No entanto, o examinando apresenta déficit atencional, o que sugere um quadro de **Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade- TDAH CID-10 F90.2**, e características acentuada para **Transtorno do Espectro do Autismo**, onde foi avaliado durante os atendimentos dificuldades na regulação emocional, e expressar suas emoções.

Desta forma, sugiro o encaminhamento de para a especialidade médica Neurologia ou psiquiatria para mais esclarecimentos, e também acompanhamento da neuropsicologia.

A avaliação proposta é de caráter introdutório, os dados desta Avaliação Neuropsicológica são sigilosos, sendo de interesse apenas dos profissionais envolvidos e com validade de até 12 meses.

6. REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION - APA. Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. Porto Alegre: Artmed, 2014.

BENCZIK, EDYLEINE BELLINI PERONI. Escala de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade ETDAH-AD: versão adolescentes e adultos. 1ª Ed. São Paulo: Vetor, 2013.

RUEDA, Fabian. Bateria Psicológica para Avaliação da Atenção- BPA2. Volume 2. Vetor Editora

Jaboatão dos Guararapes 24 de Fevereiro de 2025



Anderson Pinheiro de Souza
Psicólogo/Neuropsicólogo
CRP-02/23796

Anderson Pinheiro de Souza
Psicólogo e Especialista em Neuropsicologia
CRP/02-23796